EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 81022
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-20 10:44:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ANDRES ORLANDO EGIDI MALDONADO ZUNIGA			RUN	: 5.304.150-7
F.Nac	: 24-08-1944	Edad	: 79 AÑOS, 6 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: CHACAY S/N			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 99992478		
Fecha Ingreso	: 17-03-2024	Fecha Egreso	: 2024-03-20 10:44:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. ACV isquémico Putaminal izquierdo. ATE. Dia 3
2. Crisis hipertensiva tipo emergencia resuelta
3. HTA
4. DM2 mal controlada (HbA1C 8.7)

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Pte Diestro, mRS 0-1, autovalente, familiar refiere ultima vez visto bien la noche anterior al acostarse, notan a las 10am aprox dificultad para articular palabras y desviación de rasgos faciales, ingresa en crisis hipertensiva 200/100mnhg con Obs ACV para evaluacion por neurologia
Se toma conocimiento del caso 18/3/24
TAC de cerebro con isquemia aguda putaminal izquierda
Se mantiene con cifras de PA elevadas
Neurológico: Vigil, con afasia mixta predominio motor, disartria severa
Pupilas isocoricas 3mm, RFM +/+, CV impresionan conservados con reflejo de amenaza, MOC conservados, PFC derecha leve, sensibilidad facial algesica, lengua protruye central
Motor: PMP negativa, arreflexia aquiliana y patelar, hiporeflexia bicipital y tricipital.
Sensibilidad: algesica conservada
Cerebelo: poco evaluable no comprende ordenes
Signos meníngeos negativos.
Buena evolucion clinica sin intercurrencias durante 72hrs, persiste con trastorno del lenguaje sin deficit motor. se decide alta medica con HODOM para continuar rehabilitacion Fonoaudiologica y estudio cardiovascular ambulatorio.

PLAN DE MANEJO:

Estudio etiológico ambulatorio
- Ecocardiograma
- Holter de Ritmo

HODOM Seguimiento por Fonoaudiología
Control en Poli de Neuro en 10 dias
Mantener dobleantiagregacion plaquetaria y estatinas a dosis altas

INDICACIONES AL ALTA

1. LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
2. CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
3. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 2 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
4. ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
5. AMLODIPINO COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
6. HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
7. FAMOTIDINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
8. CLOPIDROGEL COMPRIMIDO 75 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
9. Insulina NPH 14unds am y 10unds pm

EXÁMENES Y RESULTADOS

19/3/24 RPR negativo, HbA1c 8.7, leuc 7300, Hb 16.8, Hto 50.9, Plaq 121000, Colest 185, TAG 155, Glic 182. Vit B12 193 Vit D 14.2
AngioTAC de cerebro y cuello: con estenosis M1 izquierda con enfermedad ateromatosa en sifones carotideos mayor a derecha
TAC de Cerebro : infarto agudo putaminal izquierdo, con isquemia antigua frontal derecha

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO